

대장암 진단 첫 30일

결장암 · 직장암 · MMR 검사와 치료 순서

처음 진단받은 환자와 보호자를 위한 핵심 정리 · 질문 · 행동 가이드

ApuDa 「암 진단 첫 30일」 시리즈 04

MINI 무료 배포판 · Instagram 구독자용 · 2026년 10월 개정 2판

같은 대장암이라도 결장암과 직장암은 치료 순서가 다릅니다.

이 책을 펴기 전에

- 이 책은 **일반적인 환자교육 자료**입니다. 나의 병기, 치료 순서, 약 선택, 예후는 담당 의료진과 함께 결정합니다.
- 의학정보 확인일: **2026.10.04** · 참고 지침: NCCN Clinical Practice Guidelines in Oncology — Colon Cancer / Rectal Cancer, Version 2.2026 외 국내 자료(본문 끝 「근거와 한계」 참고)
- 약의 국내 허가·건강보험 급여 기준과 제도(산정특례·지원사업)는 자주 바뀝니다. 실제 적용 전 병원 원무과·국민건강보험공단(1577-1000)에서 다시 확인하세요.
- 이 책은 NCCN이 검토하거나 승인한 자료가 아니며, ApuDa가 독자적으로 쓴 환자교육 저작물입니다.

이 MINI판에 대하여

이 MINI판은 진단 후 첫 30일 동안 **안전하게 판단하는 데 꼭 필요한 내용만** 담았습니다. 응급 신호, 진단 직후 할 일, 병리·병기의 핵심, 치료 흐름, 진료실 질문, 한 장 요약은 완전판과 같습니다. 30일 일자별 실행 로드맵, 치료별 준비·회복 가이드, 한국 제도·보험 서류 안내, 마음 돌보기와 보호자 가이드, 워크북은 완전판에 있습니다.

PART 1. 진단 첫 주 — 정확히 알기

1장. 먼저 구분하세요: 결장암과 직장암, 그리고 MMR

30초 요약

- 결장암은 대개 수술 먼저, 직장암(특히 중·하부)은 수술 전 치료(항암·방사선) 먼저가 많습니다.
- MMR/MSI 검사는 모든 대장암 환자에게 권고됩니다. 결과가 치료 순서를 바꾸고, 유전(린치증후군) 선별에도 쓰입니다. **치료 시작 전에** 결과를 확인하세요.
- 용종 안의 암(조기암)은 내시경 절제로 끝낼 수도, 추가 수술이 필요할 수도 있습니다.

결과지에 적힌 말	뜻	볼 곳
선종, 고도이형성	전암병변	담당의 확인
용종 내 암(악성 용종)	내시경 절제 후 병리로 추가 수술 결정	6장
결장 선암	결장암	6장
직장 선암(대개 항문에서 약 15cm 이내, 최종 구분은 MRI 등으로)	직장암	7장
점액선암, 반지세포암	선암의 세부형	담당의 확인

첫 30일의 지도

순서	할 일	시기
①	조직검사·위치(결장/직장) 확인	Day 0-3
②	CT(흉부·복부·골반), 직장암은 골반 MRI, CEA	Day 3-14
③	MMR/MSI 결과	Day 7-14
④	수술 먼저 vs 수술 전 치료 먼저 결정	Day 8-21
⑤	가임력·장루 상담, 치료 준비	Day 14-30

오늘 물어볼 질문

- 1. 제 암은 결장암인가요, 직장암인가요? 항문에서 몇 cm인가요?
- 2. MMR/MSI 검사는 했나요? 결과는 언제 나오나요?
- 3. 수술을 먼저 하나요, 다른 치료를 먼저 하나요?

2장. 기다리지 않는 신호

⚠ 응급 상자 — 바로 연락하거나 응급실로

- 배가 부풀고 방귀·대변이 멈추며 토함(장폐색)
- 많은 양의 혈변, 어지럼·실신
- 점점 심해지는 복통과 발열(천공·감염)
- 수술 후: 열·복통 악화·복부 팽만, 배액 색 변화, 상처 고름
- 장루 배출이 묽고 많아지며 어지러움·소변 감소(탈수)
- 한쪽 다리 부종, 갑작스러운 숨참·흉통(혈전)
- 항암 중 38°C 이상 발열, 하루 4~6회 이상 설사, 흉통, 심한 입안 혈음으로 못 먹음
- 스스로를 해치고 싶은 생각 → ☎ 109, 119

본문 목록:

1. 장폐색은 수술이나 스텐트가 필요할 수 있어 빨리 평가합니다.
2. 대량 출혈·어지럼은 응급입니다.
3. 수술 후 발열·복통은 연결 부위 누출 가능성이 있습니다.
4. 회장루는 수분 손실이 커서 탈수가 빨리 옵니다.
5. 암과 수술은 혈전 위험을 높입니다.
6. 항암 중 발열·심한 설사·홍통은 연락 기준입니다.

3장. 진단 뒤 72시간

30초 요약: 오늘은 ① 조직검사 결과·위치 확인 ② 대장암 진료팀 예약 ③ 아이 계획이 있다면 메모(가임력 상담).

오늘 할 일 (3개)

- ☐ 조직검사 결과지와 내시경 소견(위치·항문에서 거리)
- ☐ 대장항문외과·종양내과 진료 예약
- ☐ 아이 계획이 있거나 아직 정하지 못했다면 **치료 전 가임력 상담**을 첫 진료에서 요청 — 골반 방사선·항암은 생식 기능에 영향을 줄 수 있습니다

이번 주 할 일

- ☐ CT(흉부·복부·골반), 직장암은 골반 MRI, CEA 혈액검사
- ☐ 조영제 CT 전에 신장 질환, 당뇨약(메트포르민) 복용, 이전 조영제 알레르기가 있으면 미리 알리기
- ☐ MMR/MSI 검사 의뢰 확인
- ☐ 가족력(대장암·자궁내막암·위암 등) 정리 — 젊은 나이 진단·가족력이면 유전상담
- ☐ 산정특례 신청(확진일로부터 30일 이내)

- □ 변비·혈변·복통 기록

오늘 물어볼 질문

1. 조직검사와 내시경 소견을 설명해 주시겠어요?
2. 병기 검사는 무엇을 하나요?
3. 가임력 상담과 유전상담이 필요한가요?

4장. 병기와 검사

30초 요약: 병기는 장벽을 뚫은 깊이(T)·림프절(N)·전이(M)로 정합니다. 직장암은 **골반 MRI**로 종양과 주변 경계(직장간막)의 거리를 봅니다.

병기	쉬운 뜻	결장암 흔한 치료	직장암 흔한 치료
1기	장벽 안쪽	수술	수술(일부 국소절제)
2기	장벽을 뚫음, 림프절 없음	수술 ± 고위험이면 보조항암	수술 전 치료 → 수술
3기	림프절 전이	수술 → 보조항암	수술 전 치료(TNT) → 수술 또는 비수술 추적
4기	간·폐 등 전이	전신치료 ± 전이 절제	같음

- 판독지의 작은 결절·"불확정" 병변은 전이를 뜻하지 않을 수 있습니다. MRI나 추적 CT로 확인합니다. 간에 애매한 병변이 보이면 간 특이 조영제를 쓴 간 MRI가 개수·위치를 가장 정확히 보여 주는 검사로 쓰입니다.
- CEA는 진단보다 **추적에 쓰는 표지자**입니다. 정상이어도 암이 없는 것은 아닙니다.

■ **완전판에서 이어집니다** — 직장암 MRI 판독지 단어장, 병리보고서 읽기

5장. MMR/MSI와 유전, 바이오마커

30초 요약

- MMR 검사 결과지에는 네 가지 단백질(MLH1·PMS2·MSH2·MSH6) 이름이 나옵니다. 어떤 단백질이 없는지에 따라 **유전 상담 필요성**이 달라집니다.
- **dMMR/MSI-H**는 면역치료가 잘 듣는 경우가 많아 치료 순서가 바뀔 수 있습니다.
- 전이성에서는 **RAS(KRAS·NRAS)·BRAF·HER2**를 추가로 봅니다. ctDNA(혈액 종양 DNA)는 연구·선별적으로 쓰이며 아직 모든 환자의 표준 검사는 아닙니다.

■ **완전판에서 이어집니다** — 린치증후군 가족 검사 3단계와 평생 검진 개요

바이오마커 기록: MMR _ (**없어진 단백질** _) · MSI _ · **RAS** _ · BRAF _ · **HER2** _ · CEA _____

PART 2. 치료 결정 — 2~3주차

6장. 결장암 치료

30초 요약

- 대부분 수술(복강경·로봇 포함)로 해당 결장과 림프절을 함께 땁니다.
 - 3기는 보조항암: 재발 위험(T4·N2 여부)과 약 조합에 따라 **3개월 또는 6개월**로 정할 수 있습니다. 기간이 짧으면 손발 저림 위험이 줄어듭니다. 국내 안내 자료에는 6개월로만 적힌 경우가 많은데, 3개월은 주로 재발 위험이 낮은 3기에서 주사 + 먹는 항암제 조합을 쓸 때 논의됩니다.
 - 2기 고위험은 보조항암을 상의하고, **dMMR 2기**는 항암 이득이 적어 판단이 다릅니다.
 - **dMMR 결장암**에서 수술 전 면역치료가 새로 논의되고 있습니다(최신 근거·국내 허가·급여 확인 필요).
- 악성 용종: 내시경 절제 후 병리(깊이·절제면·림프관 침범·분화도)로 추가 수술 여부를 정합니다.
 - 장이 막힌 경우: 응급 수술 또는 스텐트로 먼저 길을 연 뒤 수술합니다.

■ **완전판에서 이어집니다** — 보조항암 일정표와 손발 저림 자가 점검

7장. 직장암 치료

30초 요약

- 국소진행 직장암은 **수술 전 치료** → **수술**이 기본이며, 요즘은 항암과 방사선을 모두 수술 전에 하는 **전체 선행치료(TNT)**가 많습니다.
 - 방사선은 **1주(5회) 단기** 또는 **5~6주 장기** 방식이 있고, 일부는 방사선 없이 항암만 먼저 하기도 합니다.
 - 치료 후 종양이 사라진 **임상적 완전관해**면 수술 없이 촘촘히 추적하는 **비수술 추적(watch-and-wait)**을 상의할 수 있습니다.
 - **dMMR 직장암**은 수술 전 면역치료가 먼저 논의될 수 있고, 일부는 수술·방사선 없이 추적하는 길이 시행되고 있습니다(전문센터 상의·국내 허가·급여 확인 필요). 다만 2026년 현재 국내 건강보험 급여는 주로 전이성 dMMR 대장암의 1차 치료에 인정되고, 수술 전 면역치료는 임상연구나 개별 판단으로 제한적으로 시행됩니다. → **MMR 결과를 치료 시작 전에 확인**하세요.
- 골반 방사선 전 **가임력(정자·난자) 보존** 상담을 받을 수 있는지 물어보세요.
 - 항문에서 가까운 암은 괄약근 보존 가능성과 **임시·영구 장루** 가능성을 수술 전에 설명 듣습니다.

■ **완전판에서 이어집니다** — 비수술 추적 체크리스트, 단기·장기 방사선 비교

8장. 수술과 장루

30초 요약: 장루는 대부분 **임시(회장루)**이며 몇 달 뒤 닫는 수술을 합니다. 영구 장루라도 일상·운동·여행이 가능합니다. **장루전문간호사**와 수술 전에 위치를 표시하고 교육을 받으세요.

- 직장암 수술 뒤에는 잦은 변·급박변(저위전방절제증후군, LARS)이 생길 수 있습니다. 골반저 재활·식이·약으로 좋아질 수 있습니다. 대개 수술 후 6개월쯤 크게 나아지고 이후 2년 정도에 걸쳐 조금씩 더 좋아지지만, 수술 전과 똑같아지지는 않아 일부 불편이 남을 수 있습니다.

■ **완전판에서 이어집니다** — 장루 생활 Q&A, 장루 용품·장애 등록

9장. 전이성 대장암

30초 요약: 바이오마커와 **원발 위치(좌/우)**에 따라 치료 조합이 달라집니다. 간·폐 전이가 적으면 **전이 절제**로 완치를 목표로 하는 경우도 있습니다.

상황	범주(국내 허가·급여 확인 필요)
MSI-H/dMMR	면역치료 중심
RAS·BRAF 야생형 + 좌측	항암 + 항EGFR 항체
우측 또는 RAS 변이	항암 + 항VEGF(혈관신생억제)
BRAF V600E	표적 병용
HER2 증폭, KRAS G12C, NTRK	해당 표적 범주
간·폐 전이 소수	절제·소작·SBRT로 근치 목표 가능

국내 급여 참고(2026년 8월 국내 공공 암정보 기준, 바뀔 수 있음): 항VEGF 항체는 RAS 결과와 관계없이 1·2차에서, 항EGFR 항체는 RAS 야생형 1차에서 정해진 항암 조합과 함께 쓸 때 급여가 됩니다. 일부 새 약은 아직 급여 협상 중이라 비용 차이가 클 수 있으니 처방 전에 원무과에 확인하세요.

진행·전이로 진단받았다면

30초 요약

- 전이가 있어도 치료 선택지는 있습니다. 치료 목표가 **암을 조절하며 오래, 덜 아프게 사는 것**으로 바뀌는 경우가 많습니다.
- **완화(지지)의료는 마지막 단계의 돌봄이 아닙니다.** 진단 시점부터 항암치료와 함께 통증·피로·숨참·불안을 줄이는 치료입니다.
- 첫 진료에서 "제 치료 목표는 무엇인가요?"를 꼭 물어보세요.

■ 완전판에서 이어집니다

- 치료 목표 대화법, 완화의료·호스피스 이용법, 사전연명의료의향서, 치료를 쉬는 선택
- 2차 소견 받는 법, 병원 선택 기준, 다학제 진료, 임상시험 찾는 법

PART 3. 30일 실행 로드맵

■ **완전판에서 이어집니다** — 30일 실행 로드맵(일자별 체크리스트)

PART 4. 치료 중·후의 몸과 마음

배변·신체상·운동

30초 요약: 배변 변화와 장루로 외출·관계가 두려워지는 것은 흔한 반응입니다. 장루전문간호사·환우회와 이야기할 수 있습니다. 꾸준한 신체활동은 재발 위험을 낮추는 데 도움이 될 수 있다는 연구가 있습니다.

 **완전판에서 이어집니다** — 단계별 운동, LARS 관리

추적

항목	일반적 예시(병기에 따라)
진찰·CEA	처음 2년 3~6개월마다, 이후 6개월마다(5년까지)
CT	2~3기 이상 처음 몇 년간 6~12개월마다
대장내시경	수술 1년 후, 이후 결과에 따라
직장암 비수술 추적	더 촘촘한 MRI·내시경

 **완전판에서 이어집니다** — 치료 중 증상별 자가관리 표(메스꺼움·피로·입안 혈음·변비·설사·불면·탈모·피부·손발 저림)

마음 돌보기

30초 요약

- 진단 후 불안, 잠 못 들, 멍함, 화, 눈물은 **흔하고 자연스러운 반응**입니다. 약해서가 아닙니다.
- 2주 넘게 일상이 무너지거나, 스스로를 해치고 싶은 생각이 들면 **혼자 견디지 말고** 바로 도움을 요청하세요.
- 자살·정신건강 위기 상담 ☎ **109**(24시간), 응급 ☎ **119**
- 지금 마음의 고통은 0~10 중 ____ 점. 4점 이상이면 다음 진료에서 그대로 말하세요.

■ 완전판에서 이어집니다

- 고통 온도계, 불안을 다루는 5분 방법, 상담 연결 경로, '내 탓' 생각 다루기
- 보호자 역할 나누기, 아이에게 알리는 법, 보호자 휴가 제도, 보호자 자신의 돌봄
- 직장 병행 전략, 회사에 말하는 범위, 복귀 계획
- 치료 중 식사·운동 원칙과 피해야 할 것

PART 5. 돈 · 서류 · 제도

한국에서 꼭 챙길 제도와 서류

30초 요약

1. **산정특례 등록**: 암 확진 후 **30일 이내**에 신청하면 확진일부터 건강보험 본인부담이 크게 줄어듭니다(급여 항목 기준 5%). 진단받은 병원 원무과에 "산정특례 신청"을 오늘 물어보세요.
2. **서류는 처음부터 두 부씩**: 병리보고서, 영상 판독지, 진단서는 보험·회사·2차 소견에 반복해서 쓰입니다.
3. **제도는 바뀔니다**: 금액·기준은 2026년 10월 기준이며, 공단(1577-1000)·원무과에서 다시 확인합니다.

■ **완전판에서 이어집니다** — 산정특례 신청 절차, 의료비 지원제도, 실손·암보험 서류, 회사 서류 체크리스트

PART 6. 진료실 도구

진료실 질문 모음 — 한 번에 3개씩

진단 직후에는 1~3번, 치료를 정할 때는 4~7번, 치료 시작 전후에는 8~10번 중 **3개만** 골라 가세요. 보호자가 답을 적으면 충분합니다. 1. 결장암인가요, 직장암인가요? 위치는요? 2. 병기와 림프절 상태는요? 3. MMR/MSI 결과는요? 유전상담이 필요한가요? 4. 수술 먼저인가요, 수술 전 치료 먼저인가요? 5. 장루 가능성은? 임시인가요, 영구인가요? 6. 보조항암은 몇 개월인가요? 7. 직장암이라면 비수술 추적이 가능한가요? 8. 가임력 보존 상담을 받을 수 있나요? 9. 바로 연락해야 할 증상은 무엇인가요? 10. 전이가 있다면 RAS·BRAF·HER2 결과는요?

내 대장암 한 장 요약

항목	내 기록
위치	결장(우/좌) / 직장(항문에서 ____cm)
병기	임상 _ → 병리 _
MMR/MSI	_____
RAS/BRAF/HER2	_____
CEA	_____
첫 치료	수술 / TNT / 면역치료 / 전신치료
장루	없음 / 임시 / 영구
가임력	해당 없음 / 상담

오늘 꼭 물을 3가지: ① MMR 결과는? ② 수술이 먼저인가요? ③ 장루와 가임력은?

■ 완전판에서 이어집니다

- 같은 진단을 받은 세 사람의 30일(가상 사례)
- 대장암 용어사전
- 대장암 자주 묻는 질문 12
- 진료실 대화법(15분 진료를 30분처럼), 검사 준비 카드(CT·MRI·PET·조직검사·내시경)
- 워크북: 진료 기록지, 7일 증상 일지, 약·보충제 목록, 연락처 카드, 30일 체크 달력

근거와 한계

- **참고 지침:** NCCN Clinical Practice Guidelines in Oncology (NCCN Guidelines®) — Colon Cancer / Rectal Cancer, Version 2.2026. NCCN의 표·알고리즘·문장을 옮기지 않고, 환자 언어로 새로 썼습니다.
- **국내 자료:** 국가암지식정보센터(www.cancer.go.kr) 대장암 정보, 대한대장항문학회 자료, 국민건강보험공단 산정특례·장애 등록 안내
- **국가암지식정보센터 자료의 이용 방식:** 이 책은 국가암지식정보센터(구 국가암정보센터)의 글·표·그림을 옮기거나 고쳐 쓰지 않았습니다. 같은 사실을 대조·확인하는 데 참고했고, 문장은 ApuDa가 새로 썼습니다(센터 저작권 안내의 이용조건: 비영리·저작권 표시·내용 변경 금지·영리 이용 시 사전 협의를 따릅니다).
- **출처:** 보건복지부·국립암센터 국가암지식정보센터 — 사실 확인에 참고한 자료(센터 문장·그림은 신지 않음). 더 자세한 암 정보와 상담은

www.cancer.go.kr, ☎ 1577-8899(평일 9~18시).

- **의학정보 확인일:** 2026.10.04. 약의 국내 허가·급여, 면역치료·표적치료 적용 기준, 제도 금액은 바뀔 수 있습니다.
- **감수:** ApuDa 「첫 30일」 감수단(전문의 30인·환자 36인·편집자문 3인 역할 기반 **AI 사전 검토단**)의 1·2차 검토를 반영했습니다. 이 검토는 실제 면허 의료진의 최종 감수를 대신하지 않습니다. 출판본에는 실제 감수자 명단이 별도 표기됩니다.
- 이 책은 NCCN이 검토·승인한 자료가 아니며, NCCN과 무관한 ApuDa의 독자적 환자교육 저작물입니다.
- 이 자료는 일반적인 환자교육용이며 개인의 진단·처방·치료 결정을 대신하지 않습니다.

완전판에는 이런 내용이 더 있습니다

- 직장암 MRI 판독지 단어장, 병리보고서 읽기
- 림치증후군 가족 검사 3단계와 평생 검진 개요
- 보조항암 일정표와 손발 저림 자가 점검
- 비수술 추적 체크리스트, 단기·장기 방사선 비교
- 장루 생활 Q&A, 장루 용품·장애 등록
- 치료 목표 대화법, 완화의료·호스피스 이용법, 사전연명의료의향서, 치료를 쉬는 선택
- 2차 소견 받는 법, 병원 선택 기준, 다학제 진료, 임상시험 찾는 법
- 30일 실행 로드맵(일자별 체크리스트)
- 단계별 운동, LARS 관리
- 치료 중 증상별 자가관리 표(메스꺼움·피로·입안 혈음·변비·설사·불면·탈모·피부·손발 저림)
- 고통 온도계, 불안을 다루는 5분 방법, 상담 연결 경로, '내 탓' 생각 다루기
- 보호자 역할 나누기, 아이에게 알리는 법, 보호자 휴가 제도, 보호자 자신의 돌봄

- 직장 병행 전략, 회사에 말하는 범위, 복귀 계획
 - 치료 중 식사·운동 원칙과 피해야 할 것
 - 산정특례 신청 절차, 의료비 지원제도, 실손·암보험 서류, 회사 서류 체크리스트
 - 같은 진단을 받은 세 사람의 30일(가상 사례)
 - 대장암 용어사전
 - 대장암 자주 묻는 질문 12
 - 진료실 대화법(15분 진료를 30분처럼), 검사 준비 카드(CT·MRI·PET·조직검사·내시경)
 - 워크북: 진료 기록지, 7일 증상 일지, 약·보충제 목록, 연락처 카드, 30일 체크달력
-

ApuDa.app — 더 많은 암·질환 교육 콘텐츠와 업데이트 Instagram 구독자 무료 배포판 · 상업적 재배포 금지

ApuDa | 아프지만, 다행이다. · <https://apuda.app/>